

7827 漢康-KY (Hanchor)

報告日期：2026/05/29

研究員：吳和善 (Jason Wu)

壹、投資建議

興櫃參考價：145 元

現金增資承銷價：120 元

上市日期：2026/05/29

一. CD47/SIRP α 免疫療法全球市場價值顯著

由於新一代免疫治療 CD47/SIRP α 相關免疫療法是當前癌症治療領域的重要新興技術，因此國際藥廠藉由併購或授權方式進行布局，其中包含 Gilead 藥廠於 2020 年以 49 億美元收購 Forty Seven 取得當時位於 1b 期臨床試驗的藥物-CD47 單株抗體 Magrolimab。國際藥廠 Pfizer 則在 2021 年以 22.6 億美元併購 Trillium 並取得當時處於 1b/2 期試驗的 SIRP α -Fc 融合蛋白 TTI-621、TTI-622。由於相關併購或授權案例顯示國際藥廠對於 CD47/SIRP α 靶點的生物藥高度興趣，即使臨床仍在 1 期仍有藥廠願出高價進行併購。

二. HCB101 已於試驗中展現多適應症療效

HCB101 基底為 IgG4-Fc 再加上經由 FBDB™平台基因工程改良的 SIRP α 融合蛋白而成的生物新藥，能精準地利用自身的 SIRP α 卡住腫瘤細胞的 CD47，使得巨噬細胞能重新辨識並「吃掉」癌細胞。由於 HCB101 的關鍵優勢在於不針對紅血球而僅針對腫瘤細胞的 CD47 因此病患不會有嚴重貧血的副作用並且具備更高親和力，針對實體瘤與血液瘤提高可能的療效，臨床前測試對多項癌症有治療潛力且與不同抗體之聯合用藥，也在 CDX 模型中展現了更優的療效。

三. HCB101 臨床試驗推進，並取得美 FDA 孤兒藥資格

HCB101 人體臨床一期試驗經歷過劑量探索試驗且皆完成臨床一期試驗證實 100%無安全性疑慮，而全球臨床 1b/2a 期試驗已從單藥驗證推進至多種具臨床意義的聯合治療開發架構已於 3M25 開始陸續於美國、中國與台灣展開 1b/2a 期臨床試驗，並主要針對頭頸癌、三陰性乳癌、胃癌、結直腸癌和小細胞癌等六種癌症。以目前狀況來看，HCB101 在 1b/2a 期的聯合治療中維持了良好的安全性與極寬的治療區間，並看到高於目前標準療法的客觀反應率 (ORR)、高反應率及長效腫瘤控制成績。除此之外，HCB101 於 2026.02.12 獲得 FDA 針對全類型胃癌的孤兒藥資格，有助於公司在後續研發及上市的優勢。

貳、公司概況

一. 公司簡介

漢康生技由劉世高博士創立於 2020 年，資本額為 13.02 億元。漢康生技是一家專注於全球創新癌症免疫藥物開發的國際級生技公司，並擁有完全自主智慧財產權的獨創技術平台，建構了從新藥研發、製程開發、製劑分析、轉譯醫學評估、到全球臨床運營與商務拓展一條龍的高效運營模式。

公司營運據點涵蓋了臺北、舊金山及上海，其中總部和研發中心在臺北，而舊金山辦公室負責全球商務拓展及臨床運營等業務範疇，上海辦公室則配置法務法規、市場調研及臨床運營等團隊。位於內湖科學園區研發中心，佔地約 650 坪，具備完整的細胞株建構、製程上下游開發並有同時飼養近 2,000 隻實驗小鼠的實驗動物房和細胞學實驗室，能夠高效率地將新藥概念推進至臨床前（IND enabling）階段。

在公司團隊部分，漢康生技的核心主管具備罕見的「跨國藥廠管理經驗」與「將產品成功推向國際市場的實績」，說明如下：

- 創辦人兼執行長—劉世高 博士（Scott Liu）：
美國普渡大學生科博士，曾任 Bristol Myers Squibb（BMS）負責 QC/QA 職能，並於 Amgen 任職。並於 2009 年共同創立復宏漢霖（Henlius）並推動多款生物藥上市，並帶領公司市值最高達 1,800 億新台幣，目前復宏漢霖已發展為中國具國際競爭力的生物製藥企業，生物相似藥全球排名約第 15 位。而後將 CMC（化學製造與管控）、臨床前與全球臨床運營實戰經驗悉數注入漢康。
- 總裁暨醫療長—陸英明 博士（Alvin Luk）：
加州大學舊金山分校（UCSF）神經科學博士、哈佛商學院 MBA，曾在 Novartis、Biogen、Bayer、Genentech 等全球製藥業 30 年醫學領導經驗，並主導美國 FDA 批准的首款基因治療產品 LUXTURN[®] 成功上市，參與過 22 款上市藥物的開發，並遞交過超過 250 項全球註冊申請。
- 商發長—叢越華 博士（Yuehua Tsung）：
德國康斯坦茨大學有機化學博士，曾任職於 PolyTherics、F-star Biotech、先聲藥業歐亞知名生命科學企業，具備卓越的跨國授權與引進（BD）經驗，職涯主導之關鍵策略交易累計總金額規模達 4~12 億美元。
- 研發長—翟文武 博士（Wenwu Zhai）：
英國曼徹斯特大學博士、劍橋大學博士後，擁有超過 20 年治療性抗體與蛋白藥物開發經驗，從臨床前至 IND 及 I 期試驗

均有深厚實績，並擁有 107 項抗體相關已發表或獲准專利。

由於公司團隊具備深厚生技研發背景及國際大廠經歷，掌握蛋白藥物研發的核心技術、蛋白生物藥製程開發關鍵技術，故能快速完成融合蛋白生物新藥的藥效學的評估並熟知 FDA 和歐盟的標準要求，因此漢康從研發專案到臨床試驗申報僅需花 2.3 年，顯著少於一般藥廠平均需 5.5 年的時間。

由於公司具備深厚研發背景及實務經驗，因此自創立以來，累計募資已達 1.065 億美元，其股東陣容極其堅強，包含深耕生命科學領域的頂尖國際創投與大型集團，包含美商維梧資本（Vivo Capital）、瑞伏醫藥創投（Panacea Venture）、正大集團（CP Group）、安富資本（Affinity Capital）、韓國 KIP、元大亞洲、東安投資等機構，使得公司在不管資金或臨床進度推動上皆有顯著進展，其中包含 6M25 與港股上市藥廠-復宏漢霖簽訂大中華區授權合約，授權金高達 2.02 億美元並已於 9M25 認列首付金 1,000 萬美元，並陸續與多家國際大藥廠洽談授權。另外在製程則於 6M24 與德國莎多利斯 (Sartorius, SRT.DE) 宣布簽訂合作意向書、1M26 與藥明生物 (2269.HK) 簽署戰略合作協定

二. 公司營運概況與展望

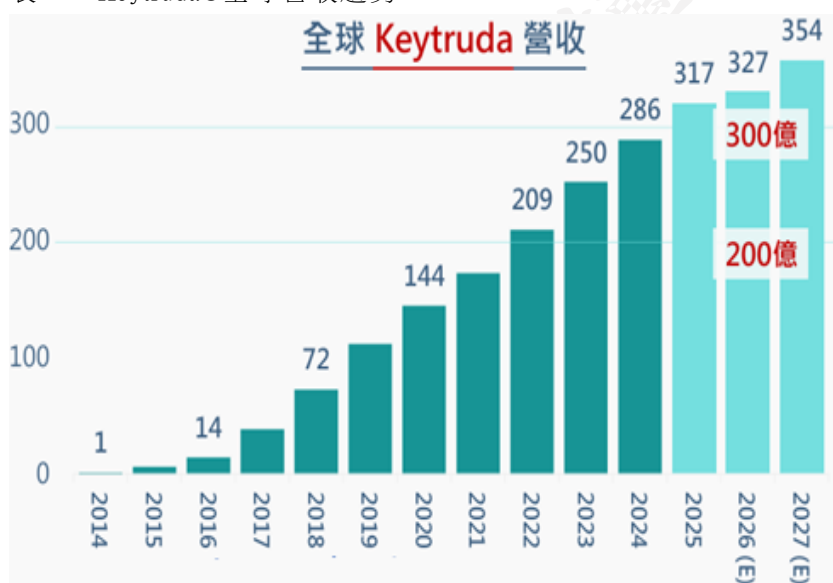
1. 癌症免疫療法轉為市場顯學

癌症治療可分為傳統化學療法與癌症免疫療法，傳統化學療法是利用藥物直接殺死快速分裂的細胞，雖然具備治療效果但也引起如掉髮、噁心、免疫力下降等副作用。而癌症免疫療法透過激活人體免疫系統來攻擊癌細胞、副作用較少，且對某些難治型癌症效果顯著，但缺點是起效時間較長，並非對所有患者都有反應。

由於癌症免疫療法是透過增強人體自身免疫系統來對抗癌細胞，免疫系統的主要目標為清除體內外來或非自身細胞物質，可分為先天免疫系統與適應性免疫系統，再透過改善腫瘤微環境以增強免疫細胞的功能。先天性免疫是人體第一道防線，對病原體或異常細胞進行非特異性攻擊，反應快速，無需事先接觸抗原，並由關鍵細胞如巨噬細胞、自然殺手細胞、樹突細胞來啟動免疫反應，相關療法如 CD47 抑制劑、NK 細胞療法；適應性免疫較先天性免疫反應慢，但其高度專一且具備免疫記憶，可長期保護身體不受同類病原體或癌細胞侵害，主要藉由 T 細胞、B 細胞進行免疫反應，相關療法如 PD-1/PDL1 抑制劑、CAR-T 細胞療法。最後則是改善腫瘤微環境，藉由免疫療法則透過影響免疫細胞、血管和代謝，來抑制腫瘤生長，主要療法如 VEGF 抑制劑和 IDO 抑制劑。

根據 Grand View Research 報告顯示 2025 年全球癌症免疫療法市場為 2,857 億美元，2026-2033 年 CAGR 為 9.0%。以市場規模來看單株抗體-免疫檢查點抑制劑佔市場達 65%，其中 Keytruda® (默沙東藥廠)、Opdivo® (時美施貴寶藥廠) 為現今市場代表性的免疫檢查點抑制劑，藉由通過阻斷 PD-1/PD-L1 或 CTLA-4 訊號，避免癌細胞躲避免疫系統的攻擊，增強 T 細胞的抗癌能力。而免疫治療生物藥 Keytruda® (PD-1 單抗) 於過去十年銷售增 280 倍，2025 年銷售達已超過 300 億美元，且被核准應用於超過 20 個適應症。

表一、Keytruda® 全球營收趨勢



資料來源：Merck & Co

不過用 PD-1/PD-L1 抑制劑之臨床有效率(ORR)平均僅約 20%~30% 且存在一定的局限性包含 (1). 有效率有限與抗藥性問題：PD-1/PD-L1 免疫檢查點抑制劑之臨床有效率(ORR)平均僅約 20~30%，且部分腫瘤在治療初期有效，隨著時間推移可能發展出抗藥性。(2). 免疫副作用影響患者治療意願：過度活化免疫系統導致自體免疫性副作用將影響多個器官，可能導致患者中止治療。(3). 治療成本高：PD-1/PD-L1 抑制劑屬於高價位藥物，一年的治療費用可能超過 10~20 萬美元，對患者的經濟負擔較大。而上述的限制將有望透過聯合治療與新型免疫療法，進一步提升癌症治療效果，如 PD-1/PD-L1 合併 CTLA-4 抑制劑或化療或放療、PD-1/PDL1 + VEGF 抑制劑，或是新一代免疫療法如 CD47/SIRPα 免疫療法、雙特異性抗體、CAR-T、細胞療法..等。

2. CD47/SIRP α 免疫療法全球市場價值顯著

由於新一代免疫治療 CD47/SIRP α 相關免疫療法是當前癌症治療領域的重要新興技術，因此國際藥廠藉由併購或授權方式進行布局，其中包含 Gilead 藥廠於 2020 年以 49 億美元收購 Forty Seven 取得當時位於 1b 期臨床試驗的藥物-CD47 單株抗體 Magrolimab，該藥物主要用於血液腫瘤及實體瘤的免疫療法。國際藥廠 Pfizer 則在 2021 年以 22.6 億美元併購 Trillium 並取得當時處於 1b/2 期試驗的 SIRP α -Fc 融合蛋白 TTI-621、TTI-622。由於相關併購或授權案例顯示國際藥廠對於 CD47/SIRP α 靶點的生物藥高度興趣，即使臨床仍在 1 期仍有藥廠願出高價進行併購。

表二、國際藥廠於 CD47/SIRP α 靶點生物藥交易

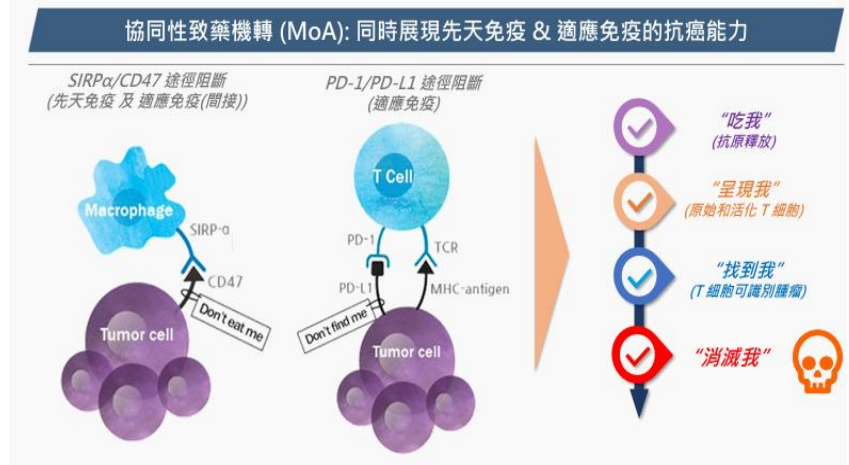
類型	代數	交易類型	授權/被併購方	接收/併購方	交易時 臨床進度	發生 年	交易金額 (億美元)
抗 CD47 單抗	1st	商業授權	Forty Seven	ONO	1 期	2019	1.04
抗 CD47 單抗	1st	商業授權	I-Mab (天境生物)	Abbvie (艾伯維)	1 期	2020	17.4
抗 CD47 單抗	1st	併購	Forty Seven	Gilead (吉立亞)	1b 期	2020	49.0
抗 CD47 單抗	1st	商業授權	Immune Oncia	3DMed	1 期	2021	4.63
SIRP α -Fc 融合蛋白	2nd	併購	Trillium	Pfizer (輝瑞)	1b/2 期	2021	22.6
抗 SIRP α 單抗	1st	商業授權	Sairopa	Exelixis	1 期	2022	3.35
CD47 抑制劑	--	商業授權	Innobation Bio	Luminatus	1 期	2022	未公開

資料來源：各公司，宏遠投顧彙整

3. 漢康技術平台 FBDB™ 具備開發多靶點生物藥優勢

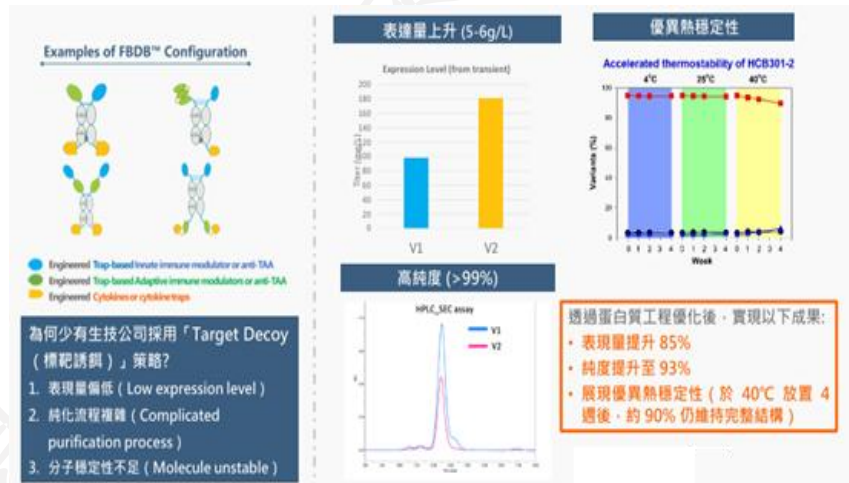
漢康關鍵核心技術是基於 Fc 設計的具特殊分子構型的生物藥 FBDB™ (Fc-Based Designer Biologics) 技術平臺，藉由抗體 Fc 區域為骨架將由蛋白質工程改造後的多種抗癌作用大分子建構在其骨架上，其中抗癌大分子是利用經結構設計改造所產生的改良型 Ligand Trap (配體陷阱) 技術與蛋白質結構工程技術優化而成的腫瘤免疫生物藥。而改良型 Ligand Trap (配體陷阱) 為基礎的 FBDB™ 技術平臺，其特色是藉基因與蛋白質工程改造免疫細胞上的受體，使其結構高度相似且具有更高的親和力、更低的副作用，使其它們無法和其在免疫細胞上天然的受體相結合降低配體對免疫細胞的抑制作用。由於 Fc 具備能延長蛋白藥物在血液中的半衰期亦有讓後續蛋白藥物的純化之功能，故經工程後的受體接上 Fc 骨架成一新藥可鎖定腫瘤細胞上(或其分泌的)相關配體 (Ligand) 並做專一性結合以啟動人體的免疫系統，帶動免疫系統中的巨噬細胞和 T 細胞辨識、吞噬並攻擊並消除癌細胞。

圖一、漢康的 FBDB™ 平臺的特色



資料來源：漢康-KY

圖二、FBDB™ 平臺優勢



資料來源：漢康-KY

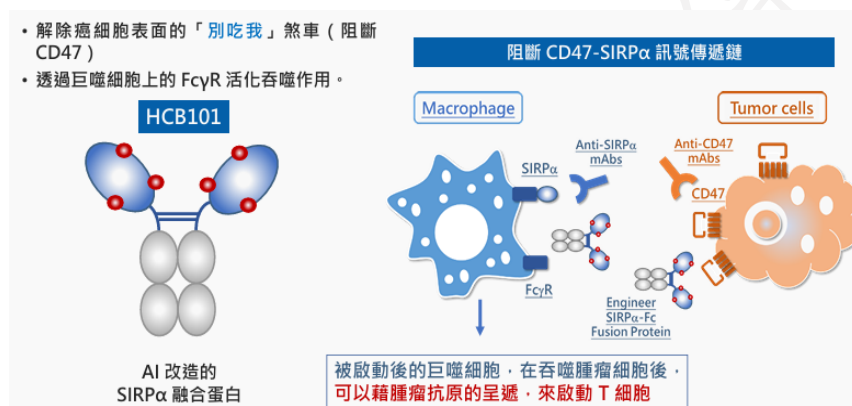
漢康以 FBDB™ 平臺為基礎開發出 8 個以上的融合蛋白生物藥自研專案進行中，目前第一個生物藥 HCB101 已進入臨床二期外，第二個藥物 HCB301 也已通過美國食藥局(FDA)許可進入臨床一期試驗收案，其他候選藥如 HCB206、HCB303 也有望進入臨床階段。

4.HCB101 已於試驗中展現多適應症療效

HCB101 基底為 IgG4-Fc 再加上經由 FBDB™ 平台基因工程改良的 SIRP α 融合蛋白而成的生物新藥，相對於過往 CD47 藥物設計具有不同之處有較好的療效以及降低血液毒性副作用。由於腫瘤細胞表面通常會大量表達 CD47 與巨噬細胞上的 SIRP α 受體結合，向免疫系統發出「別吃我」(Don't Eat Me) 的信號，藉此逃避巨噬細胞攻擊。但經改造後的 SIRP α 使得 HCB101 與腫瘤細胞表面 CD47

的親和力增加約 100 倍，因此提升阻斷腫瘤細胞 CD47 “不要吃我” 傳遞訊號能力提升約 1,000 倍，HCB101 能精準地利用自身的 SIRP α 卡住腫瘤細胞的 CD47，使得巨噬細胞能重新辨識並「吃掉」癌細胞。降低血液毒性副作用則是漢康於篩選潛力候選蛋白過程中，篩選與紅血球上的 CD47 低結合親和力的 SIRP α ，故降低貧血等血液學副作用並保有與腫瘤細胞 CD47 結合之高專一性。

圖三、HCB101 作用機理



資料來源：漢康-KY

由於公司持續優化 HCB101 之優勢，針對目前臨床上 CD47/SIRP α 相關生物藥品的第一代的抗 CD47 單抗、第二代野生型的抗 SIRP α 融合蛋白及第三代的改良型的 SIRP α -Fc 融合蛋白進行開發藥物如下所述：

表三、CD47/SIRP α 途徑的生物藥特性

分類	說明
第一代為 anti-CD47 單株抗體	具備高度毒殺腫瘤能力但安全性太低。最具代表性的 Magrolimab 已於 3Q24 三期解盲失敗，主因為嚴重副作用導致病患死亡。
第二代為野生型 SIRP α 融合蛋白	安全性大幅提升但 CD47 親和力低，使得激活巨噬細胞吞噬腫瘤的功效降低。具代表性即 TTI622，目前進行臨床二期實驗。
第三代為基因工程改造之 SIRP α 融合蛋白	代表藥物為 ALX148，與 CD47 具高結合合力但單藥使用不具任何吞噬腫瘤效果，因其本身的不活化的 IgG1 不具功能且不會誘發抗體依賴性細胞吞噬作用(ADCP)的功能，具備提升安全性優點但必須進行合併療法，靠另一個抗體的完整的 IgG1 的 ADCP 功能才可能發揮功效。合併療法則易引發副作用產生，費用也比較高。

資料來源：漢康-KY、宏遠匯整

相較於第一~三代的 CD47/SIRP α 標靶藥物，HCB101 保留了第二代的藥物的安全性，也提高了有效性。在血液腫瘤動物模型中，HCB101 的療效與第一代藥物 Magrolimab 相當，且在多種實體瘤動物模型中，療效都顯著優於第一代和第二代藥物。而在第三代藥物中，HCB101 單藥就具有療效，不需要合併療法。

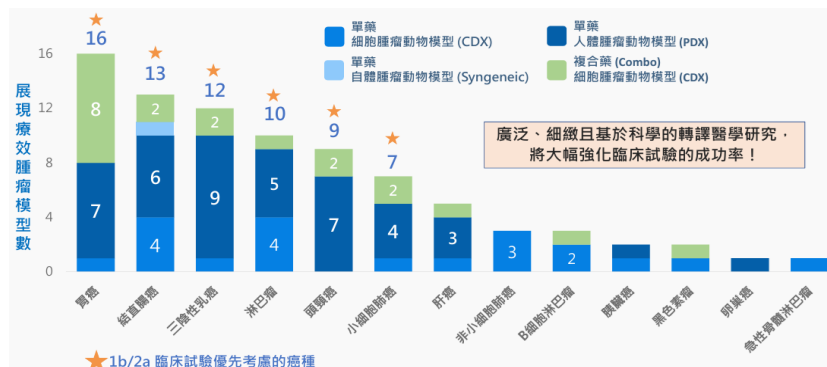
表四、HCB101 與標靶 CD47 藥物比較

	第 1 代 抗 CD47 抗體	第 2 代 野生型 SIRPα	第 3 代 基因 SIRPα	第 3.5 代 基因工程 SIRPα		
競爭者	Gilead Sciences	I-MAB 天境生物	Pfizer, Inc.	ImmuneOnco 宜明昂科	ALX Oncology	漢康生技
分子構型	單株抗體 (anti-CD47)	單株抗體 (anti-CD47)	野生型 SIRPα融合蛋白	野生型 SIRPα融合蛋白	基因工程 SIRPα融合蛋白	基因工程 SIRPα融合蛋白
IgG-Fc 構型	IgG4	IgG4	IgG4	IgG1	不活化 IgG1	IgG4
臨床耐受劑量 (患者承受安全劑量)	1 mg/kg	30 mg/kg	18 mg/kg	2 mg/kg	10 mg/kg (複合劑量)	36 mg/kg
臨床前療效 (血液瘤/實體瘤)	+/+	+/-	+/-	+/-	+/+ (只複合藥有效)	+/+
臨床階段	臨床 3 期 (FDA 中止)	臨床三期 (中國境內)	臨床 2 期	臨床 2 期	臨床 2 & 3 期	臨床 1 & 2 期
優勢	有療效	高安全性	高安全性	高安全性	高安全性	高安全性 高療效
劣勢	安全疑慮	低療效 (授權終止合作)	低療效	低療效	單藥無療效	無

資料來源：漢康-KY

由於 HCB101 的關鍵優勢在於不針對紅血球而僅針對腫瘤細胞的 CD47 因此病患不會有嚴重貧血的副作用並且具備更高親和力，針對實體瘤與血液瘤提高可能的療效，而 IgG4 生物藥骨架設計不僅阻斷 SIRP α /CD47 路徑且可吸引巨噬細胞並攻擊腫瘤細胞，具備療效及成本優勢。HCB101 的臨床前測試對多項癌症有治療潛力，其中包含胃癌、結直腸癌、三陰性乳癌、頭頸癌、小細胞肺癌、肝癌與卵巢癌..等有較高功效。而 HCB101 與不同抗體(包括 PD-1, HER-2, EGFR, VEGF 及 VEGFR 單抗)之聯合用藥，也在 CDX 模型中展現了更優的療效，而腫瘤抑制率(Tumor growth inhibition, TGI)高於 80%均顯著優於或其他標準治療抗體的單藥治療療效。

圖四、HCB101 用於腫瘤模型之療效



資料來源：漢康-KY

本報告僅供宏遠投顧內部及客戶參考，雖已力求正確與完整，但因時間及市場客觀因素改變所造成產業、市場或個股之相關條件改變，投資人需自行考量投資之實際狀況與風險，本公司恕不負擔任何法律責任及做任何保證。非經本公司同意，不得將本報告加以引用或轉載

5.HCB101 臨床試驗持續推進，並取得美 FDA 孤兒藥資格

HCB101 人體臨床一期試驗受試者 67 位，其中多為經歷過多線治療的晚期實體瘤與復發的患者包含 54 位為實體癌、13 位血液癌。收案型態為多國多中心進行收案，包含美國 12 位、中國 41 位與台灣 14 位，患者經歷過從 0.08mg/kg 至 36mg/kg 的 13 個劑量組探索試驗且皆完成臨床一期試驗證實 100%無安全性疑慮。

表五、HCB101 臨床一期概況

分類	說明
安全性與耐受性	1.劑量成功遞增至 36 mg/kg，仍未達到最大耐受劑量界線 2.未觀察到 ≥ 3 級的嚴重貧血（Anemia）副作用，也沒有因累積毒性導致的連續安全性停藥 3.絕大多數治療相關不良反應（TRAEs）為輕微的 1-2 級，而發生的劑量限制性毒性（DLTs）僅為血小板低下（無出血狀況），且證實為暫時性（transient）且可自行恢復。
治療濃度區間	過往 CD47 藥物雖然可殺死癌細胞但也會攻擊紅血球且在臨床開發中血液毒性造成的「治療濃度區間」過窄的問題。而 HCB101 是使用 SIRP α -Fc 融合蛋白設計，可以在體內維持更久、更穩定的有效濃度，因為安全性高，更適合與其他抗癌藥物合併使用。
藥物動力學（PK）與受體佔有率（RO）	1.HCB101 在 0.08~36 mg/kg 劑量範圍內呈現線性藥代動力學（Linear PK），8-36 mg/kg 半衰期約為 2-4 2.劑量 ≥ 5.12 mg/kg 時，峰值 CD47 受體佔有率可達 ~99%；在 ≥ 8 mg/kg 時，整個給藥週期內都能穩定維持 $\geq 90\%$ 的高受體佔有率 3.臨床療效與高受體佔有率的劑量（約 5.12~8 mg/kg）呈現高度一致性。
單藥即具備長效的初步抗腫瘤療效	1.2 例部分緩解(Partial Response, PR, 定義為單一或數個最長的直徑總數減少 30%以上，並且維持四星期之久)，包含 1 例頭頸癌（5.12 mg/kg，腫瘤縮小 42%，療效持續超過 65 週）及 1 例非何杰金氏淋巴瘤（8 mg/kg，腫瘤縮小 89.5%，療效持續超過 16 週） 2.11 例疾病穩定(Stable disease, SD, 定義為腫瘤有縮小，但未縮小 30%以上；腫瘤長大，但未增長 20%以上)：涵蓋大腸直腸癌（CRC）、卵巢癌、頭頸癌等，部分患者疾病穩定控制時間超過 4-9 個月。

資料來源：漢康-KY

而在 HCB101 全球臨床 1b/2a 期試驗部分，已從單藥驗證推進至多種具臨床意義的聯合治療開發架構，藉由 HCB101 與標準療法的合併使用，來突破目前治療瓶頸，已於 3M25 開始陸續於美國、中國與台灣展開 1b/2a 期臨床試驗，並主要針對頭頸癌、三陰性乳癌、胃癌、結直腸癌和小細胞癌等六種癌症，評估 HCB101 與標準治療聯合用藥之療效。以目前狀況來看，HCB101 在 1b/2a 期的聯合治療中維持了良好的安全性與極寬的治療區間，並看到高於目前標準療法的客觀反應率(ORR)、高反應率及長效腫瘤控制成績。

表六、HCB101 全球臨床 1b/2a 期概況

病症	簡述
二線 HER2 陰性胃癌	HCB101 聯合 Ramucirumab 標靶藥物與 Paclitaxel 紫杉醇的合併使用、受試者約 30~40 位，截至 4M26，在 5.12-8 mg/kg 的中劑量組別中，10 位可評估患者呈現 80%的客觀反應率(ORR)、100%的疾病控制率(DCR)，多位患者腫瘤縮小幅度介於 30%~78%之間，中位無惡化存活期(mPFS)為 26 週。 註：對比標準療法(Ramucirumab 與 Paclitaxel)之 ORR 僅 26.5%、mPFS 約 4.4 個月。
一線 HER2 陽性胃癌	HCB101 聯合雙重 HER2 標靶藥物 (Trastuzumab + Pertuzumab)，在目前於 6 位可評估患者中，呈現 83.3%的客觀反應率 (ORR)，其中 5 例確認為部分緩解(PR)，與 100%的疾病控制率(DCR)，而所有可評估患者均觀察到腫瘤縮小，幅度介於 30%~60%之間。
頭頸癌	HCB101 聯合 Pembrolizumab (keytruda)標靶藥物的合併使用，在 1.28mg/kg 低劑量組，共有 3 名患者可評估療效，達到 100%的疾病控制率(DCR)，包括 1 例完全緩解(CR)、1 例部分緩解(PR)及 1 例疾病穩定(SD)。其中，1 例 CR 已在後續評估中獲確認，目標淋巴結短徑縮小至 10 mm 以下，舊病灶完全消失也未出現新病灶。
二線大腸直腸癌	HCB101 聯合 1.Encorafenib 與 Cetuximab、2.Bevacizumab 或 Cetuximab 標靶藥物與 Folfox/Folfiri 化療藥的合併使用。6 位可評估患者達到 100%疾病控制率(DCR)，其中 1 位確認為部分緩解(PR)、5 位達疾病穩定 (SD)，且其中一位的腫瘤無惡化期(PFS)長達 9 個月，較目前標準療法約 47 個月長。

資料來源：漢康-KY

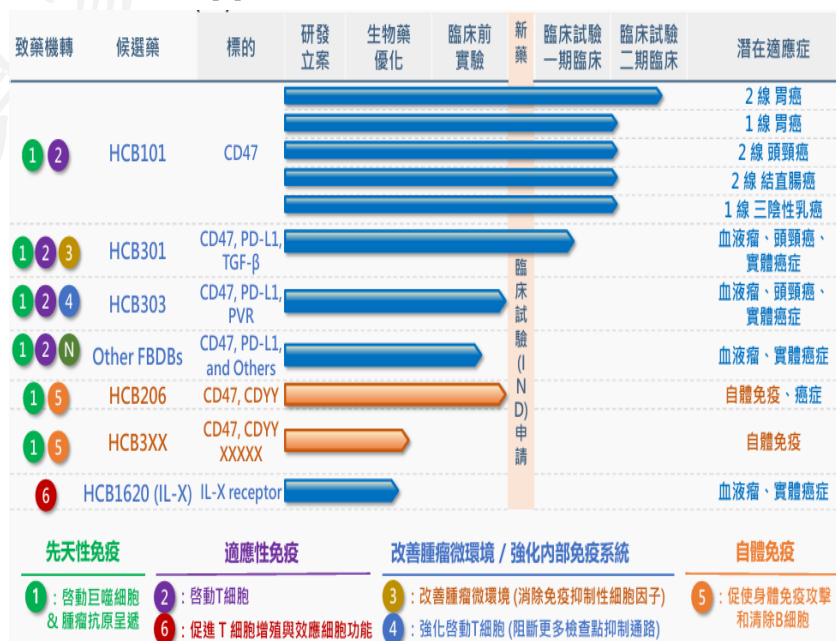
由於美國 FDA 看好 HCB101 潛力可由晚期胃腺癌擴大至廣泛胃癌治療，因此 HCB101 於 2026.02.12 獲得 FDA 針對全類型胃癌的孤兒藥資格，顯示 FDA 認為 HCB101 對於廣泛的胃癌類型都可能有益，有助於公司在後續取得上市後 7 年獨佔權、50% 所得稅抵免、豁免費用、較小規模臨床試驗許可等優勢。

5.HCB301 三臂融合蛋白生物藥也開始進入臨床一期收案

除了進度最快 HCB101 之外，尚有 HCB301 也進入臨床一期中。HCB301 為全新 First-in-class 的三臂融合蛋白生物藥，分別對應 CD47/SIRP α 、PD-L1、TGF- β 三個靶點，故可針對 PD-1/PD-L1 標靶療法產生抗藥性的機轉加以克服進而增加療效。由於 TGF- β 是一種在腫瘤微環境中抑制免疫系統的因子，會降低 T 細胞及自然殺手細胞(NK Cell)的攻擊能力，因此抑制 TGF- β 也為 HCB301 所著重的策略之一。HCB301 可同時啟動兩大免疫系統-先天性免疫與適應性反應以及可抑制轉化生長因子，目前已於動物腫瘤模型上看到抑制頭頸癌的效果，靈長類試驗亦證實其安全性。

由於全球有超過 200 個抗體藥物取得至少一個監管機構的批准並有 2,800 多個抗體或融合蛋白候選藥物進行臨床試驗中。若以占比來看，單抗藥物約 68.5%、雙抗藥物 28.4%、三抗藥物僅佔 3.1%。由於全球尚無三功能抗體或融合蛋白獲得批准，因此 HCB301 這類蛋白藥物市場可期。

表七、漢康-KY pipeline 進度



資料來源：漢康-KY

本報告僅供宏遠投顧內部及客戶參考，雖已力求正確與完整，但因時間及市場客觀因素改變所造成產業、市場或個股之相關條件改變，投資人需自行考量投資之實際狀況與風險，本公司恕不負擔任何法律責任及做任何保證。非經本公司同意，不得將本報告加以引用或轉載

叁、財務簡表

單位：百萬元

	2024(A)	25H1 (A)	25Q3 (A)	25Q4 (A)	2025(A)	26Q1 (F)
營業收入	-	-	312	-	312	-
營業毛利	-	-	312	-	312	-
營業費用	952	236	190	-294	132	320
營業利益	-952	-236	122	-254	-368	-320
營業外淨收入（支出）	-402	8	-19	10	-1	-1
稅前純益	-1,354	-229	104	-244	-369	-321
稅後純益	-1,354	-229	71	-233	-392	-330
稅後 EPS（元）	-20.36	-1.91	0.58	-1.79	-2.26	-2.10
股本	1,200	1,200	1,301	1,302	1,302	1,302
每股淨值（元）	1.93	2.45	5.85	5.11	5.11	3.29

註：漢康-KY 於 2024/10/25 股東會決議普通股每股面額由美金 0.002 元變更為新臺幣 10 元。